

УДК:616.6-07(574)

Х.А.Абисатов, Н.Т.Балтабеков, Н.Ю.Насрытдинова

Казахский Национальный Медицинский Университетим. С.Д. Асфендиярова

Проблемы и перспективы организации ранней диагностики злокачественных новообразований в Казахстане

Аннотация. Среди наиболее актуальных проблем медицинской науки и Здравоохранения одно из первых мест занимает проблема рака.

Высокий уровень смертности, поздняя диагностика, огромный процент инвалидизации трудоспособного населения привел к тому, что проблема онкологии перешла из области медицинской в социальную. Одним из главных и наиболее перспективных направлений противораковой борьбы является ранняя диагностика.

Ключевые слова: онкология, диагностика, поликлиника, реинженеринг.

Актуальность

Злокачественные новообразования являются важной медицинской и социальной проблемой здравоохранения нашей Республики. Высокий уровень смертности, поздняя диагностика, огромный процент инвалидизации трудоспособного населения привел к тому, что проблема онкологии перешла из области медицинской в социальную.

За последние 5 лет правительство Республики Казахстан резко увеличило затраты на онкологию, доведя бюджет республиканской онкологии до 1 миллиарда евро и обеспечило 100% население бесплатно сверх дорогостоящими противоопухолевыми лекарственными препаратами. Ни в одной из республик постсоветского пространства нет такого выбора бесплатной химио- и таргетной терапии, как в нашей стране.

Одними из первых на территории СНГ в Казахстане введен Канцер регистр, позволяющий отслеживать в режиме онлайн весь маршрут и лечение онкологического больного.

Министерство здравоохранения, Казахский НИИ онкологии и радиологии, совместно с управлениями здравоохранения городов и областей Казахстана проводят большую организационную работу среди медицинских работников- выездные циклы по обучению врачей общей лечебной сети ранним симптомам онкологических заболеваний, обучение казахстанских онкологов в ведущих онкологических центрах России, Франции, Южной Кореи, Индии и Японии.

Большую помощь онкологам оказывают неправительственные общественные организации, помогая закупать на средства спонсоров дорогостоящее диагностическое оборудование, организовывая различные мастер классы с участием зарубежных специалистов, проводя среди населения разъяснительную работу по ранней диагностике онкологических заболеваний. Многие общественные организации совместно с управлениями здравоохранения контролируют качество и доступность медицинской по-

мощи онкологическим больным, что очень важно как для государства, так и для онкологических пациентов.

Однако, несмотря на огромные материальные и организационно административные усилия правительства, медицинской общественности показатели смертности от злокачественных новообразований снизились незначительно и далеки от желаемых, как это произошло в кардиологии и фтизиатрии.

Так в Казахстане ежегодно выявляется около 30 000 новых случаев злокачественных новообразований из них более 50% составляют пациенты с распространенными и запущенными стадиями заболевания.

Лечение этих пациентов требует совместного применения сложных расширенных операций, высоко технологичной лучевой терапии, длительных курсов дорогостоящей, токсичной химиотерапии. Такое лечение тяжело переносится больным и сопровождается значительными затратами государства и только 15- 20% больных с III-IV стадией переживают 5 летний срок.

Поэтому все возрастающие затраты на лечение не приносят ожидаемых результатов по значительному снижению смертности от онкологической патологии.

В нашей республике также проводятся большое количество мероприятий по улучшению ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний. Казахстан лидирует среди стран СНГ по количеству и проценту охвата населения скринингом по раннему выявлению злокачественных заболеваний и все же уровень ранней диагностики остается низким/

Реинженеринг причин поздней диагностики и анкетирование врачей ПМСП в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, проведенное Казахским НИИ онкологии и радиологии в 2013-2014 годах выявил следующие проблемы ранней диагностики:

Загруженность и как следствие высокая текучесть кадров среди участковых терапевтов.

Отсутствие материальной мотивации врачей ПМСП за конкретный результат по улучшению ранней диагностики,

При проведении скрининга онкологических заболеваний проводится упор на охват (количество), а не качество исследований.

Отсутствие солидарной ответственности населения за свое здоровье и не желание проходить профилактические осмотры и скрининг.

Недостаточная обеспеченность эндоскопическим и рентгенологическим оборудованием в поликлиниках на местах.

Нехватка квалифицированных узких специалистов – особенно рентгенологов, и эндоскопистов и морфологов.

Низкий уровень онкологической настороженности среди врачей ПМСП, (только 10% правильно ответили при

тестировании на знание алгоритма ранней диагностики).

Перспективы улучшения ранней диагностики, на наш взгляд, необходимо разделить на первоочередные и отсроченные, а по материальным затратам на низко и высоко затратные.

Первоочередные и мало затратные мероприятия включают:

Усовершенствование существующих принципов мотивации врачей ПМСП на выявление только первых стадий, а не отсутствие запущенных случаев, как существует на сегодняшний день.

Введение материальной мотивации врачей ПМСП за выявление аблигатногопредрака. Это приведет как снижению онкологической заболеваемости, так и улучшению ранней диагностики.

Ежегодное тестирование и обучение врачей ПМСП ранней диагностики за счет выездных циклов.

Введение административных мер по повышению солидарной ответственности населения за не прохождение скринингов, также как и за не уплату налогов или коммунальных услуг.

Отсроченные и высокозатратные мероприятия по ранней диагностике.

Улучшение материальной базы ПМСП,особенно за счет закупа современного эндоскопического и цифрового рентгенологического оборудования в регионах с высокой смертностью.

Пересмотр протоколов диагностики на уровне ПМСП и повышение материальных затрат «гарантированного минимума» обследования на уровне общей лечебной сети при подозрении на онкологическое заболевание.

Выделение государственных грантов на улучшение ранней диагностики онкологических заболеваний.

Включить в состав всех онкодиспансеровлечебно-диагностические отделения для проведения бесплатной и максимально быстрой диагностики злокачественных новообразований.

Обязать онкологическую службу проводить диагностику, лечение и диспансеризацию аблигатногопредрака для онкологических заболеваний,входящих в первую десятку смертности,для этого дополнительно разработать протоколы диагностики и лечения аблигатногопредрака.

Заключение

Таким образом, для снижения смертности от злокачественных заболеваний одним из наиболее перспективных методов является кооперация совместных усилий по ранней диагностики онкологической службы и организаций ПМСП.

Список литературы

- 1 Ferlay J., Autier P., Boniollet M. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 // Ann.Oncol. -2007.-Vol. 18, N 3.-P. 581–592.
- 2 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).-Алматы, 2010-2013.
- 3 The Information Centre. National Lung Cancer Audit. Key findings about the quality of care for people with lung cancer in England incorporating headline and completeness data from Wales. Report for the audit period 2006. Leeds: The Information Centre, 2006. [http://www.ic.nhs.uk/webfiles/ Services/NCASP/Cancer/Lung%20](http://www.ic.nhs.uk/webfiles/Services/NCASP/Cancer/Lung%20) (accessed 13 Jul 2011)

Тұжырым

Х.А.Абисатов, Н.Т.Балтабеков, Н.Ю.Насрытдинова
С.Д. Асфендияров ат. Қазақтың Ұлттық
Медициналық Университеті

Медицина ғылымының және денсаулық сақтауда көкейкесті мәселелерінің ішінде обыр мәселесі бірінші орынды алады

Өлімнің жоғары деңгейі, кеш анықталу, жұмысқа жарамды халықтың мүгедектіктігінің алып пайызы, онкология мәселесінің медицинадан әлеуметтік аумағына өтуіне алып соқтырды. Обырға қарсы күрестің басты және болашақ бағыттың бірі – обырды ерте анықтау болып табылады.

Түйінді сөздер онкология, диагностика, поликлиника, реинженеринг.

Summary

X.A.Abisatov, Baltabekov N.T., Nasrytdinova N.U.
Kazakh National Medical University. SD Asfendiyarov
Problems and prospects of the organization early diagnosis of malignant neoplasms in Kazakhstan

Among the most urgent problems of medical science and Health care is one of the first places is the problem of cancer.

The high mortality rate, late diagnosis, a huge percentage of disability in the working population has led to the fact that the problem of Oncology has passed from the medical social. One of the major and most promising anticancer fight is early diagnosis.

Key words: oncology, diagnostics, clinic, reengineering.